7. El Diagnóstico Clínico

Prometeo ha muerto.

ELIAS CANETTI, *La conciencia de las palabras*

Gez, que no es médico, deja asentado un diagnóstico clínico: *su mal*, el de Lafinur, está localizado en determinado órgano específico, el hígado. Podría habérselo ahorrado, escribir solamente: "espantóse el caballo que montaba y lo arrojó sobre unas piedras del camino. El golpe fue recio, ocasionándole una grave lesión. Su naturaleza delicada por el exceso de trabajo no le permitió reaccionar de su mal y después de terribles padecimientos...". Y listo, sin implantar ningún "hígado". Sería igual, la prótesis funciona así también. Porque cualquiera podría ir aceptando, ya, por más defensor de Gez que sea, que si esta versión de los hechos, esta información de cómo muere Lafinur, no fuese una ficción inventada, el autor consignaría la fuente de donde la saca. ¿A qué se debe, entonces, que el biógrafo desee impostar un diagnóstico clínico? Aventuro una hipótesis sociolingüística: siendo, en la época de Gez, el discurso médico-científico más prestigioso que el literario ficcional de la biografía histórica, podría tratarse de un caso de *diglosia*, donde el hablante considera que ese otro lenguaje, que no le pertenece o no siente como propio, es superior al corriente en una cantidad de aspectos[1]. En la primera década del siglo XX es normal creer -así como en la actualidad lo sigue siendo, aunque no queda clara la razón- que el lenguaje médico es más elegante, lógico y apto para expresar pensamientos importantes. Esta creencia se

[1] Ferguson, Charles A. "Diglossia", *Word*, Linguistic Circle of New York, Nueva York, vol. 15, 1959, p. 237-238.

verifica incluso entre personas cuya competencia en el campo médico es limitada. ¿Qué podría Gez creer, que está mejorando, al ponerse la careta de doctor? Como apunta Canetti, el efecto de la careta es sobre todo *hacia afuera*. "La máscara es intocable y establece una distancia entre el espectador y ella"[2]. Me siento tentado a pensar que, cuando imposta un vocabulario médico -donde aparece una "grave lesión", en vez de la "herida" familiar a la literatura histórica; y un órgano emblemático de la patología, el hígado- lo que pretende es autorizar su relato con un prestigio axiomático indisputable (lo mismo haría al prefijar el nombre "Juan Crisóstomo Lafinur" con la abreviatura "Dr.", en el título del libro), estableciendo cierta distancia que no debe ser franqueada. Pero la contraparte de lo que la careta muestra está comprendida en lo que la misma oculta. La careta siempre tapa algo, este algo es un misterio para los que están afuera, no para quien la utiliza. Sin embargo, quien usa la careta está preocupado por que no lo descubran, tiene aprensión a que lo desenmascaren: si bien su metamorfosis puede llegar lejos, nunca debería ser total. La careta puede ser arrancada, "es el perturbador límite de la metamorfosis"[3].

Ya puedo -entonces- someter a prueba la veracidad de ese diagnóstico, que aporta Gez; ya puedo estudiar de manera crítica las probabilidades de que sea verdadero o falso, incluso de que exista ese diagnóstico en 1824, para defender que el biógrafo no esté simulando y de veras lo haya encontrado en algún sitio. Me parece factible el abordaje de este diagnóstico, desde tres ángulos convergentes:

1) Los accidentes ecuestres. Resulta pertinente investigar de qué clase son las lesiones observadas en la clínica, ordenadas de acuerdo a la frecuencia de su

---

[2] Canetti, Elías. *Masa y poder*, Muchnik Editores, Barcelona, 1977, p. 394.
[3] *Ibíd.*, p. 396.

eventualidad: contusiones, fracturas, esguinces, traumatismos craneoencefálicos, luxaciones, roturas fibrilares. A este fin, para detalle más exacto, copio y pego un fragmento de *Patología de los jinetes*, del Dr. R. Balius Juli: "La fractura de clavícula es la lesión más típica, aunque no son infrecuentes la luxación acromio-elavicular y la luxación o la fractura-luxación del hombro. En ocasiones se observan fracturas oblicuas o espiroideas de las falanges de la mano, por mantenerse ésta asida a la brida en el momento de la caída. [...] En las "caídas *con* el caballo", las lesiones revisten mayor gravedad. Cuando la caída se produce porque el caballo tropieza con el obstáculo [el artículo enfoca en las competencias con obstáculos], hombre y animal voltean al mismo tiempo hacia delante, siendo frecuente la producción de traumatismos craneoencefálicos y de fracturas vertebrales. Si el caballo cae sobre el jinete, es posible la presentación de un aplastamiento torácico, de una contusión abdominal, con lesión visceral o de lesiones óseas en las extremidades inferiores, del tipo de las fracturas diafisarias de tibia y peroné. Se han descrito luxaciones tarso-metatarsianas, al chocar las cabezas de los metatarsianos contra el suelo mientras el peso del animal se apoyaba sobre la región aquileo-calcánea, o al permanecer el pie prisionero del estribo y ser aplastado por el caballo. Mucho más raras son las disyunciones de la sínfisis pubiana, producidas por contragolpe de la silla al caerse el caballo y permanecer montado el caballero. Por mecanismo semejante, se citan casos de hidrocele traumático con derrame seroso o hemático en la vaginal del testículo o en el escroto"[4].

Resumo: en una patología *típica* de la práctica ecuestre, la contusión abdominal con *lesión visceral* se produce cuando el caballo cae *sobre* el jinete, no cuando *lo*

[4] Balius Juli, R. *Patología de los jinetes*, (PDF *on-line*), p. 76.

arroja. En las *caídas del jinete solo*, el jinete se fractura huesos, se luxa articulaciones, se rompe ligamentos, brazos, piernas, cabeza. Esto puede ser grave, o no. Acá no descarto de plano que se pueda lesionar el hígado al caer del caballo, sino que lo que describe Gez es *atípico*. Y si te ponés a pensarlo, la estadística tiene lógica: para impactar con esa parte del abdomen, Lafinur debería, en el vuelo desde la silla, girar sobre su eje en una contorsión manierista, para caer golpeando *de frente* contra las piedras de las que habla Gez. Porque si el caballo, cuando lo querés obligar a pasar por el agua, se asusta, lo que hace es empacarse. Si se asusta mucho, sale corriendo como loco y es difícil mantenerse encima, la mayor probabilidad es que te caigas sobre las piernas y ruedes sobre un costado. En cambio, si el caballo te quiere sacar de encima es otra cosa, es porque piensa que el peligro sos vos, y hace cualquier cosa para revolearte: lo peor para vos es que se pare en dos patas y se sacuda respingando para atrás. Pero si te desmonta así, caés *de espalda*. Si no tenés suerte, pegás con la cabeza o la columna. Si la sacás barata, te rompés la clavícula, la cadera, el codo, las costillas, te luxás la muñeca, te podés lesionar los riñones, la cosa anda por ahí. Entonces, 1): desde el punto de vista de la patología del jinete, el diagnóstico es atípico ya que, cuando el caballo *te arroja* contra unas piedras del camino, la probabilidad de que, entre todo lo que puedas lesionarte, sea el hígado lo que resulte dañado de gravedad, es menor al 1% de los accidentes ecuestres (incluidos coces en el abdomen), con una mortalidad muchísimo inferior. Al menos, yo no pude encontrar en internet ningún caso fatal de estas características[5].

[5]http//www.horsetalk.co.nz/2014/09/25/risk-liver-injury-riding-mishaps-not-ignored-study/#axzz4DCi8fWW9

2) Desde el punto de vista de la hepatología como disciplina médica, podría averiguar qué tipos de traumatismos de hígado derivan en la muerte del paciente. Es interesante, porque tampoco es tan normal. Transcribo, de un artículo del Dr. José Félix Patiño[6]: "La principal causa de muerte en pacientes con trauma hepático es la hemorragia con desangramiento. La segunda es la sepsis, intra o extra-abdominal. El tratamiento está orientado al control de la hemorragia y a la prevención de la infección. En aproximadamente 10-15% de los casos el trauma hepático es potencialmente fatal. [...] Los pacientes con trauma hepático presentan sintomatología que puede ser el resultado de las múltiples lesiones que lo acompañan y que, por consiguiente, no es específica." Ahora, si el caso de Lafinur se encuadra en ese 10-15% fatal, el diagnóstico de Gez no pasará la prueba de veracidad. Porque, ¿cómo se trata un hígado con hemorragias internas, que es el caso "potencialmente fatal"? Es un cuadro clínico de gravedad extrema, que requiere cirugía mayor, problema irresoluble en el año 1824. "Las heridas vasculares constituyen el mayor desafío y se acompañan de las más altas tasas de mortalidad y morbilidad. La reparación directa debe ser intentada, aun a través del parenquima lacerado o sano, por el método de la hepatotomía. En general la hemostasia se logra mejor aplicando hemoclips que con ligaduras. La hepatotomía, bajo maniobra de Pringle de oclusión de la tríada portal y utilizando fractura digital del parenquima, permite la ligadura selectiva de vasos, con excelente exposición." *Etcétera*. Procedimientos que no existen en el siglo diecinueve, la "maniobra de Pringle" recién es descripta por el cirujano James Hogarth Pringle en los *Annals of Surgery* de 1908. ¿Pero, si no podemos hacer eso, qué pasa? "La elevada mortalidad en general se debe a

[6] Patiño, José Félix. *Trauma de hígado*, Oficina de Recursos Educacionales, Departamento de Cirugía, Fundación Santa Fe de Bogotá (*disponible on-line*).

la coagulopatía que ya presentan estos pacientes cuando se emprenden los procedimientos quirúrgicos *heroicos*." Esto se complica. La hemorragia es el gran límite al desarrollo de la cirugía hepática, por ser causa de gran mortalidad perioperatoria por exanguinación (desangramiento), la primera hepatectomía mayor recién es llevada a cabo en 1888, en Berlín, por el Dr. Carl Langenbuch. Aparte, "la reintervención debe ser realizada dentro de las siguientes veinticuatro horas, en lo posible; diferir más allá de este tiempo significa un creciente riesgo de sepsis". Así, en Santiago de Chile, en 1824, la ciencia hace todo lo que está en sus manos, el cuadro no revierte y Lafinur fallece a causa de las lesiones en el hígado. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero ilustrar? Que, desde el traumatismo de hígado y el agravamiento de la lesión por hemorragia interna, hasta la muerte del paciente, sin intervención quirúrgica apropiada, no podrían haber pasado mucho más de setenta y dos horas, una semana en el caso de un milagro. Sin embargo, Lafinur se da cuenta de su condición terminal y entrega al confesor una carta (de la que hablaré más adelante) en la que menciona al "temor de la muerte que me amenaza", fechada el 26 de julio de 1824[7]. La fecha de fallecimiento de Lafinur aseverada por Gez es el 13 de agosto: habrían pasado diecisiete días entre el momento en que Lafinur reconoce que está por morirse y la fecha de su deceso. Obviamente, el 26 de julio, el día de la carta, debería ser por lo menos un día después del accidente ecuestre. Nadie, siquiera de una resistencia física extraordinaria, sobreviviría dieciocho días a un traumatismo de hígado con hemorragia interna, sin la tecnología quirúrgica apropiada. Y Gez advierte que la "naturaleza delicada" de Lafinur no le permite "reaccionar de su mal", razón por la que fallece. Esta es una segunda

[7] Ríos. *Op. cit.* P. 208 - 209.

inconsistencia: si el traumatismo al caer del caballo le ocasionara una hemorragia interna en el hígado, Lafinur no sobreviviría más de una semana, con todas las chances a su favor.

3) Debería considerarse cuál es el estado de la medicina chilena en estos años, qué clase de diagnósticos -formalmente hablando- emiten los médicos de la época. ¿Hay diagnósticos que mencionen la palabra "hígado"? ¿Quedan constancias de los diagnósticos clínicos? Porque muchas veces los escritores proyectamos sobre el pasado detalles de nuestro propio entorno, como si fuesen constantes "naturales" que existen de la misma manera que hoy, en tiempos anteriores, sin adaptar nuestras categorías a la época histórica que describimos, en divergencia con el espíritu de esos tiempos. Hegel denuncia que lo hace Tito Livio, "quien deja discurrir a los antiguos reyes, cónsules y jefes militares como lo haría tan solo un hábil abogado de ese lejano período, lo que contrasta notablemente con auténticas referencias transmitidas de la antigüedad"[8]. Más aún cuando la época de que hablamos no es tan remota, un siglo o menos, y está marcada por cambios y transiciones abruptos. Sumando que puede faltar información suficiente, es probable que te veas tentado a llenar los baches con tus proyecciones, tanto como que proyectes que el resto de los mortales presentes y futuros sufrirá tu misma falta de información.

Los cambios de paradigma a escala continental, en Europa y en América, durante las décadas inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa son abruptos, es una bisagra entre dos concepciones hegemónicas del mundo. Todo cambia, incluso la forma en que la clínica se relaciona con el cuerpo del paciente. Antes del pensamiento

[8] Cf. Hegel, G. F. W. *Filosofía de la Historia*, Ed, Claridad, Buenos Aires, 1976, p. 36.

reformador de Cabanis, no está definida una unidad de la enseñanza clínica, ni el conocimiento coincide con la práctica hospitalaria; "a este nivel -dice Foucault- las estructuras tecnológicas del saber y de la percepción no pueden aún sobreponerse: la manera en la cual se posa la mirada y la manera en la cual se la forma no se reúnen"[9]. En consecuencia, la profesión médica está marcada por un estigma, al cual el siglo XVIII es particularmente sensible: el de que es un *conocimiento incierto*: "Incertidumbre que era signo de complejidad del lado del objeto, de imperfección del lado de la ciencia"[10]. La transformación conceptual que despejaría este defecto está todavía, a principios del siglo diecinueve, en su fase germinal. Hablo de Francia.

¿Pero en Chile, en 1824? ¿Está la ciencia médica chilena en condiciones de emitir diagnósticos clínicos de la clase que relata Gez? Las "graves lesiones en el hígado" no pertenecen al lenguaje de la época. Aparte de esa cuestión lexical es necesario saber que, después de la expulsión de los jesuitas, la medicina chilena sufre una decadencia fulminante, alcanza su nivel histórico más bajo[11]. Los recursos escasos con que cuenta para atender la salud de sus habitantes están destinados principalmente a los heridos en el frente de batalla: la guerra de la Independencia recién termina en enero de 1826, con la victoria sobre los realistas en Chiloé. En ese año, el médico irlandés William Cunningham Blest, miembro de sociedades médicas prestigiosas de Londres y Dublin, radicado en Chile desde hace tres años, escribe que "es un hecho demasiado notorio (...) que hay muchos hombres que ejercen la medicina en varias partes de la república que jamás han tenido ni siquiera una educación *clásico superficial* [*sic*] (...)

---

[9] Foucault, Michel. *El nacimiento de la clínica*, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2003, p. 78.
[10] *Ibíd.* pp. 140-141.
[11] Cf. Cruz-Coke Madrid. *Op.cit*, pp. 190-191.

dando lugar por consiguiente a la opinión denigrante que tienen los hijos del país de los médicos en general"[12] Otro punto que denuncia el testigo calificado es la falta de un sistema organizado de educación médica: "Estoy en la inteligencia que cualquier persona que por algún tiempo asista a los hospitales de esta ciudad puede presentarse a un examen de su aptitud para ser un practicante en medicina", y sigue quejándose Blest de esos "hombres admitidos miembros de la profesión, sin que posean un conocimiento de los principios fundamentales de la ciencia médica, *ex nihilo, nihil fit*"[13]. No se ahorra señalar que en este país creerían suficiente "que un barbero cualesquiera, renunciando a su humilde profesión y trabajo, se dedique dos ó tres meses a la asistencia de un hospital; que aprenda de memoria algunas frases médicas; lea las páginas de algún escritor antiguo, que le enseñe que los pulmones están en el Thorax, los intestinos en el abdomen, etc., etc." El lenguaje es sencillo, la idea clara, también cuando impugna "la ley que admite un segundo orden de facultativos, denominados generalmente cirujanos de segunda clase", quienes se asemejan a "unos curanderos que existían entre los Griegos, y que vagaban de pueblo en pueblo en el ejercicio de la flebotomía ["sangría"], en la aplicación de remedios a las heridas, fracturas, etc., etc."[14]. El profesional europeo se escandaliza porque, a estos "cirujanos de segunda clase", después de un tiempo determinado se les permite rendir un examen de aptitud para ser admitidos como cirujanos de primera. La denuncia revela un estado de cosas en el cual abundan situaciones médicas atendidas por individuos que carecen del "necesario conocimiento

[12] Cf. Blest Maiben, William Cunningham. *Observaciones sobre el actual estado de la medicina en Chile, con la propuesta de un plan para su mejora*, Imprenta de la Independencia, Santiago de Chile, 1826, en *Revista Médica de Chile, Vol. 111, Nro. 4*, Abril 1983, pp. 350-357.
[13] *Ibíd*. p. 352.
[14] *Ibíd*. p. 353.

de la profesión para emprender la curación de toda enfermedad, siendo natural inferir su total ineptitud para ejercer la facultad"[15].

Hay otra causa importante por la cual es malo el estado de la medicina en Chile, en esa época. Tiene que ver con factores económicos: "la mezquina remuneración que reciben los médicos por su asistencia"[16]. Me interesa para conjeturar las posibilidades de existencia del diagnóstico de muerte dado por Gez, en la biografía oficial de Lafinur. Porque el doctor Blest reclama, amargamente, en favor de sus intereses mínimos indispensables, que "la práctica profesional de un médico en este país, ni es limitada ni reducida: aquí un profesor de medicina tiene pacientes en todas partes y en direcciones muy distantes; sus visitas deben ser sumamente repartidas y debe ser manifiesto a toda persona de reflexión, que hallándose un médico en la obligación de hacer tantas visitas cuanto alcanzan sus fuerzas en el curso del día, para juntar tantos estipendios de a 4 reales, que les costeen sus gastos y les proporcionen una pequeña parte de los placeres de la vida, es imposible que pueda dar suficiente consideración a la naturaleza de cada caso [...]. Un facultativo en medicina, para ganar 10 pesos diarios [...], se ve obligado a visitar veinte enfermos en el día: este número de visitas, agregado al tiempo que se pierde en andar de una casa a otra, y el que debe dedicarse a cada paciente, ocupa su atención desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche" ¿Por qué le sirve esto a mi investigación? Porque "los médicos, reducidos a la mendicidad y a la servidumbre, son clasificados entre los aprendices de albañiles y zapateros. [...] Los médicos, bajo el

[15] *Ibíd*. p. 354.
[16] *Ibíd*. pp. 354.

nombre de sanadores, son mal pagados y poco respetados, de consiguiente se amilanan y llegan a ser enteramente descuidados y negligentes en su profesión"[17].

En síntesis: cuando muere Lafinur, la mayoría de los que practican la medicina en Santiago son ineptos. Y los que no lo son están desganados, porque tienen que multiplicarse entre una gran cantidad de pacientes para asegurarse el sustento básico. El diagnóstico de la "grave lesión en el hígado", del que no hay rastro alguno antes de Gez, tampoco es probable que sea consignado por nadie en 1824, por la sencilla razón de que, si los médicos que ejercen entonces en Chile son percibidos como "descuidados y negligentes en su profesión", lo será, entre otras razones, porque no dejan registro documental de sus veinte "visitas-relámpago" diarias a la clientela. Claro que, en el caso de un funcionario encumbrado como Bernardo de Vera, habrá de asentarse para la posteridad cierto diagnóstico magnífico: "Un cirro canceroso, verdadero buitre de Prometeo, roía su estómago"[18].

[17] *Ibíd*. pp. 354-355.
[18] Amunátegui. *La alborada poética*, *op. cit.*, p. 383.